Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de São Sebastião do Caí

Rua São Lourenço, 1113 - Bairro: Centro - CEP: 95760000 - Fone: (51) 30985795 - Email: frsaoscai2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5007436-50.2023.8.21.0068/RS

AUTOR: VICENZO GIUSTI DOS SANTOS (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC))
AUTOR: TIANE JOHN GIUSTI (PAIS)
RÉU: CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE

SENTENÇA

Vistos os autos.

V.G.D.S, representado por sua genitora **TIANE JOHN GIUSTI**, ajuizou a presente **Ação de Obrigação de Fazer** com pedido de tutela de urgência em face de **CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE,** partes qualificadas nos autos, alegando que era beneficiário do plano de saúde operado pelo requerido. Disse que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico, necessitando a realização contínua e regular de terapias de reabilitação. Argumentou que houve a negativa do plano de saúde em manter o menor sob os cuidados da clínica VOE, em que se encontrava em tratamento há dois anos, o que motivou o ajuizamento da ação. Afirmou que o plano de saúde encaminhou uma carta e conversas no WhatsApp comunicando que redirecionaria o menor para tratamento em uma credencial no município de Caxias do Sul, sendo que o autor residia em Bom Princípio, o que acarretaria problemas relacionados à distância da viagem, transporte, além do fato de romper com o vínculo com a instituição anterior, o que poderia resultar na piora de seu quadro. Requereu a concessão de tutela de urgência para que fossem mantidos os profissionais da clínica VOE, com o custeio total pelo plano de saúde (por meio de reembolso), com as referidas horas semanais e especializações profissionais. Requereu a procedência dos pedidos, com a condenação do requerido ao fornecimento de tratamento na clínica VOE, custeando o pagamento por meio de reembolso integral, e a declaração de nulidade das cláusulas do contrato que limitavam as sessões anuais e definiam o tratamento do requerente. Pleiteou o reembolso dos valores custeados com recursos próprios, acrescido de juros e correção monetária. Requereu o benefício da Gratuidade da Justiça e juntou documentos. (evento 1, INIC1).

Concedida Gratuidade da Justiça e indeferida a tutela de urgência postulada (evento 4, DESPADEC1).

Citado (evento 10, CERTGM1), o réu apresentou contestação, suscitando a preliminar de impugnação ao valor da causa. No mérito, alegou que não havia negado o tratamento requerido pelo autor, asseverando que ele efetivamente possuía direito às terapias, que deveriam ser fornecidas em instituição credenciada, o que não poderia ser arbitrado pelo autor. Teceu comentários a respeito das cláusulas do contrato e argumentou sobre a necessidade de preservação do equilíbrio da avença e a respeito da opção do autor de realizar o tratamento junto a estabelecimento não credenciado, afirmando que disponibilizaria ao menor tratamento em clínica credenciada. Discorreu acerca do reembolso requerido, da aplicação do CDC e da ocultação de doença preexistente na adesão ao plano. Requereu a improcedência total dos pedidos e, em caso procedência, o acompanhamento dos resultados do tratamento do menor, a comprovação do comparecimento nas sessões e a observância dos limites da tabela praticada pelo plano para o reembolso das sessões requeridas. Ao fim, juntou documentos (evento 13, CONT1).

Oportunizada a indicação de outras provas a produzir (evento 19, DESPADEC1), o demandado requereu, liminarmente, que fosse determinado que o autor realizasse o tratamento na clínica credenciada e apontada pelo réu (evento 23, DOC1).

Indeferido o pedido do requerido (evento 46, DESPADEC1).

O Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos formulados na inicial (evento 57, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

I - Preliminarmente:

Impugnação ao Valor da Causa

O réu impugnou o valor atribuído à causa pelo autor, ao argumento de que o demandante requereu a Gratuidade da Justiça, o que não lhe garantia o desembolso de qualquer valor processual, mesmo com o valor exorbitante dado à causa, requerendo, assim, que fosse alterado para o valor de alçada, conforme disposição do art. 290 e art. 292, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a pretensão do autor diz respeito ao fornecimento de acompanhamento terapêutico com supervisão, musicoterapia, psicopedagogia, fonoterapia e terapia ocupacional, cujo valor é possível auferir-se, devendo o valor da causa corresponder ao custo anual do tratamento requerido.

Nesse sentido, já se pronunciou o TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA DAS TERAPIAS PELO MÉTODO ABA. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), postula cobertura com terapias multidisciplinares com: fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, metodologia ABA, psicomotricidade, julgada procedente, na origem. Quanto a Preliminar de Litispendência - inviável a extinção do processo pela litispendência com o processo de nº 50679042620198210001, pois o pleito aqui formulado é para tratamento novo, que atenda as necessidades atuais do infante, aprimorando-se o que fora anteriormente postulado nos autos da ação precedente. Preliminar afastada. Quanto a impugnação ao valor da causa - Os artigos 291 e 292 do CPC definem que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que o conteúdo econômico desta seja indeterminado, e as diretrizes para fixação desse valor. Dessa forma, o valor da causa deve corresponder ao custo anual do tratamento, nos termos do artigo 292, §2º, do CPC.Quanto ao mérito - No caso dos autos, os laudos médicos acostados pela parte autora evento 1, LAUDO3 ; evento 1, LAUDO5 ; evento 1, LAUDO6 indicam a necessidade de realização de terapia multidisciplinar pelo método ABA: fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade e psicólogo.Em consulta ao Parecer Técnico nº 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, relativo às coberturas - abordagens, técnicas e métodos - utilizados no tratamento do TEA, pode-se aferir que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a rigor, não descreve a técnica, abordagem ou método terapêutico a ser aplicado nas intervenções diagnóstico-terapêuticas a agravos à saúde sob responsabilidade profissional, permitindo a indicação, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica, o que deve ficar a cargo do profissional assistente. De acordo com a Resolução Normativa n.º 539/2022, que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, com vigência a partir de 01º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicando pelo médico assistente para tratamento do transtorno do espectro autista (TEA). Assim, é dever da operadora a cobertura do tratamento pelo método ABA, nos termos definidos na sentença.O egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu, a partir do julgamento do TEMA 1076, que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Da mesma forma, definiu que é obrigatório nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Ficou sedimentado, ainda, o entendimento que que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA (Apelação Cível, Nº 51465152220218210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-02-2024)

Assim, desacolho a preliminar de impugnação ao valor da causa.

No mais, observa-se que a demanda tramitou regularmente, não havendo nulidade a macular o feito, que está apto a julgamento.

II - Quanto ao mérito:

Do exame dos autos, observa-se que o autor pretende o reconhecimento da obrigação de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde ora requerido, em clínica particular, no município de seu domicílio.

No caso em tela, restou incontroverso que o demandante é segurado do plano de saúde (evento 1, OUT14), bem como que é portador de Deficiência Cognitiva CID 10: F84.0 e Transtorno do espectro autista (TEA), sendo que, para amenizar os sintomas das patologias, necessita submeter-se à realização contínua e regular de terapias de reabilitação, conforme indicação da médica que acompanha o menor (evento 1, LAUDO8).

LAUDO MÉDICO

Vicenzo Giusti dos Santos, em acompanhamento neurológico, CID F84.0, necessita das seguintes terapias, devido ao quadro clínico neurológico que apresenta:

Intervenção Comportamental - acompanhante terapêutica - 35h/semanais
Supervisão da Intervenção Comportamental baseado na Ciência ABA - 01x/semana
Musicoterapia - 02x/semana
Psicopedagoga - 01x/semana
Terapia Ocupacional - 01x/semana
Fonoaudióloga - 01x/semana

Já temos bem estabelecido na literatura que a intervenção precoce no autismo é o melhor tratamento. E terapias multidisciplinares são recomendadas a fim de estimular a plasticidade cerebral e tratar os diversos déficits que os pacientes com autismo apresentam.

O acompanhante terapêutico é um profissional que contribui muito com o desenvolvimento da criança com autismo na escola e em casa. A sua principal função é fazer intervenções nos comportamentos inadequados, facilitando o processo de inclusão da criança, ajudando-a em suas dificuldades, seja de socialização e/ou aprendizagem. As intervenções e os objetivos de cada acompanhamento será diferente para cada criança, por isso a importância do trabalho multidisciplinar. O acompanhante terapêutico deverá acompanhar a criança em todos os ambientes frequentados por ela.

A supervisão faz parte da terapia, para conduzir o profissional na sua intervenção e verificar possíveis falhas no processo, auxiliando o trabalho do atendente terapêutico a ter um maior sucesso nas intervenções, com evolução mais rápida e com melhor qualidade.

A musicoterapia é recomendada pois através da realização desta terapia, é possível adquirir importantes habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, socioemocionais e de comunicação. Uma parte importante do trabalho musicoterapêutico é conscientizar e instrumentalizar o brincar. Estudos recentes mostram, por exemplo, que o canto dirigido melhora atenção e autorregulação, duas funções muito importantes para o aprendizado e a comunicação. A experiência musical pode melhorar aspectos emocionais, sociais, psíquicos e cognitivos, diminui estresse e ansiedade, melhora humor e sintomas depressivos.

A intervenção psicopedagógica em casos de autismo é extremamente necessária, devido às dificuldades das crianças com o espectro também se manifestam no processo de ensino aprendizagem. As abordagens psicopedagógicas são as intervenções mais promissoras e cientificamente comprovadas para melhorar a comunicação, a interação social e os comportamentos restritos.

A terapia ocupacional trabalha as habilidades do dia-a-dia e as questões sensoriais que atrapalham o dia-a-dia dos autistas e sua convivência com crianças da sua idade e adultos. O terapeuta ocupacional estimula as questões motoras, sensoriais e neurológicas. Trabalha o processo cerebral de organização das informações, com a finalidade de dar uma resposta adaptativa adequada, estruturando e modelando as sensações do próprio corpo e do ambiente de maneira a possibilitar respostas eficientes.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de o plano de saúde direcionar o tratamento para uma clínica credenciada em município distinto daquele em que reside o autor, rompendo o vínculo terapêutico existente há dois anos com a Clínica VOE, na qual o tratamento foi iniciado e demonstrou avanços.

Restou incontroverso que o autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de terapias multidisciplinares contínuas e regulares, conforme laudo médico acostado nos autos. As terapias realizadas na Clínica VOE, situada no município de Bom Princípio, foram prescritas pelo médico assistente, sendo fundamentais para a evolução do quadro clínico do autor.

A distância entre a residência do autor e a clínica credenciada indicada pelo réu, localizada em Caxias do Sul, a aproximadamente 50 km, impõe desafios logísticos que podem acarretar impacto negativo ao bem-estar do menor. O deslocamento prolongado compromete a efetividade do tratamento, considerando as características específicas do TEA, que exigem estabilidade, rotina e previsibilidade no ambiente terapêutico.

Nesse sentido, destaca-se o princípio da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse do menor, garantidos pela Constituição Federal e pelos artigos 4º e 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que devem orientar as decisões judiciais em casos que envolvam a saúde de crianças e adolescentes.

Além disso, a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina que o plano de saúde deve observar as prescrições do médico assistente, sendo inadmissível a limitação da escolha de técnicas ou locais que comprometam a qualidade do tratamento e os avanços obtidos.

Assim, destaco:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PARTICULAR POR MEIO DE REEMBOLSO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 566/22 DA ANS. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, POIS ENVOLVEM TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, ASSIM, AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEVEM SER INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SEGUNDO A RN 566/22, DA ANS, NOS CASOS DE INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE ORIGEM, O PLANO DE SAÚDE DEVERÁ GARANTIR ATENDIMENTO PARTICULAR, MEDIANTE REEMBOLSO, OU EM CLÍNICA CREDENCIADA EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O AUTOR/AGRAVADO, QUE É PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. DAS SEIS CLÍNICAS INDICADAS PELA OPERADORA, DUAS ESTÃO LOCALIZADAS EM MUNICÍPIO DISTANTE CERCA DE 35KM DA CIDADE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR, DUAS ESTÃO LOCALIZADAS EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE E DUAS ESTÃO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, TODAVIA, NÃO DISPÕEM DE HORÁRIO PARA ATENDER O PACIENTE. RELATIVAMENTE ÀS CLÍNICAS LOCALIZADAS EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE, RESSALTA-SE QUE O AUTOR RESIDE NA ZONA SUL DA CIDADE DE PORTO ALEGRE, O QUE IMPORTA EM CERCA DE 27KM DE DISTÂNCIA DAS CLÍNICAS. NESTE CASO, CONSIDERANDO QUE **O TRATAMENTO DEVE SER REALIZADO TRÊS VEZES NA SEMANA, BEM COMO QUE O AUTOR JÁ ESTÁ REALIZANDO A FISIOTERAPIA COM PROFISSIONAL COM QUEM FIRMOU VÍNCULO, OBRIGAR O PACIENTE A FAZÊ-LO, POR CONTA PRÓPRIA, EM OUTRA CIDADE, SERIA OBSTACULIZAR O PRÓPRIO ATENDIMENTO.** IMPÕE-SE O CUSTEIO DO TRATAMENTO PRESCRITO POR VIA PARTICULAR, POR MEIO DO REEMBOLSO, COMO VEM OCORRENDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50599734820248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 24-04-2024) grifei.*

No que se refere especificamente ao custeio das terapias multidisciplinares, constata-se que o parecer técnico nº 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021[1], que trata da cobertura, abordagens, técnicas e métodos usados no tratamento do transtorno do espectro autista prevê, de forma clara, que, aos pacientes diagnosticados com transtornos do espectro autista, <u>devem ser assegurados os procedimentos necessários à assistência multiprofissional em saúde, conforme solicitação.</u>

Afora isso, o art. 3º, caput, III, "a" e "b", da Lei n° 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno e Espectro Autista, estabelece de forma categórica que a pessoa com transtorno de espectro autista tem direito ao diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, e ao atendimento multiprofissional.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ e do TJRS caminham firmes no sentido de que o propósito de oferecer o serviço multidisciplinar adequado ao infante, mesmo que em uma instituição não credenciada pela ré, é o de garantir a qualidade de vida e o seu desenvolvimento, sem qualquer limitação de sessões.

Desse teor:

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. É devida a cobertura do tratamento de psicoterapia, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)*
>
> ***Ementa:*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROFISSIONAIS EXISTENTES NA REDE CREDENCIADA. TERAPIA ABA. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora objetiva a condenação da ré ao pagamento de despesas geradas pelo tratamento de que necessita o autor, portador de Transtorno do Espectro Autista, julgada parcialmente procedente na origem. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do CDC. Inteligência da Súmula 608 do STJ.No caso em apreço, o recorrido (05 anos de idade – evento 1 – RG4 – origem), portador de Transtorno do Espectro do Autismo – TEA (CID F84.0), ajuizou a presente ação contra a agravante, postulando a realização de tratamento multidisciplinar, pelos métodos indicados, conforme prescrição médica da Dra. Gledis Lisiane Motta – Psiquiatra (evento 1 – LAUDO12 – origem). Considerando que a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar recentemente aprovou a Resolução Normativa n.º 539/2022, que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento. Tal resolução dispõe expressamente que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Destaco ainda, que em se tratando de plano de saúde que trabalha com rede credenciada, onde não há livre escolha de profissionais, o caso dos autos deve observar a regra contratual. O atendimento deve dar-se, preferencialmente, dentro da rede credenciada, sendo que em caso de inexistência de prestador dentro da rede credenciada caberá ao plano indicar prestador fora da rede credenciada, nos termos do disposto no art. 4º da RN 259 da ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO(Agravo de Instrumento, Nº 50178758220238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 23-06-2023)*
>
> ***Ementa:*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA E PROMPT. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO ONDE RESIDE O SEGURADO. COBERTURA POR REEMBOLSO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela postulada através da qual o autor busca cobertura referente ao tratamento: terapia comportamental ABA na clínica AFETIV; terapia ocupacional com integração sensorial na clínica UMANI, Fisioterapia neuro funcional UMANI, Psicomotricidade com profissional JONAS, Fonoaudiologia PROMPT, Psicopedagogia na clínica TEACOLHO, uma vez que a requerida não possui rede credenciada, respeitando-se a prescrição médica, sem limite de sessões de quaisquer dos tratamentos indicados.Em consulta ao Parecer Técnico nº 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, relativo às coberturas - abordagens, técnicas e métodos - utilizados no tratamento do TEA, pode-se aferir que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a rigor, não descreve a técnica, abordagem ou método terapêutico a ser aplicado nas intervenções diagnóstico-terapêuticas a agravos à saúde sob*

responsabilidade profissional, permitindo a indicação, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica, o que deve ficar a cargo do profissional assistente. De acordo com a Resolução Normativa n.º 539/2022, que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, com vigência a partir de 01º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicando pelo médico assistente para tratamento do transtorno do espectro autista (TEA). Assim, é dever da operadora a cobertura do tratamento pelo método indicado pelo médico assistente.É entencimento desta colenda Câmara, que o tratamento deve ser realizado, preferencialmente, dentro da rede credenciada, entretanto, em caso de inexistência de prestador dentro da rede credenciada cabe ao plano indicar prestador fora da rede credenciada, nos termos do disposto no art. 4º da RN 259 da ANS. No caso dos autos, a parte agravada não comprovou que possui clínica credenciada no município de Tapejara onde reside o menor, ainda que devidamente intimada para tanto, a operadora acostou o documento com a informação de que somente uma profissional de psicoterapia atende no Município onde reside o menor, entretanto, sem informação de aptidão para realização do tratamento pelo método ABA. As demais clínicas ou profissionais indicados atendem em cidades distantes mais de 50 Km do domicílio do menor, exigindo longo deslocamento com uma criança que, pelas características do diagnóstico, não permitem esta logística. Nesse contexto, ao menos nesse momento processual, é mais prudente manter o tratamento do menor nas clínicas onde já estão sendo realizados os tratamentos, diante da notória urgência, uma vez que se destinam a melhorar a condição de criança com transtorno do espectro autista, sendo de amplo conhecimento a existência de maior plasticidade cerebral na primeira infância e a imprescindibilidade da maior precocidade em todos os estímulos capazes de melhorar a qualidade de vida desses pacientes.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO(Agravo de Instrumento, Nº 52472651620238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 21-03-2024)

Não menos importante é mencionar a resolução normativa ANS nº 539, que passou a prever expressamente a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento.

Portanto, considera-se que é dever do plano de saúde acautelar o menor segurado, colocando à sua disposição as terapias de que necessita, conforme indicação de sua médica (evento 1, LAUDO9), as quais devem ser prestadas a contar da data do ajuizamento da presente ação e até que seja determinada a alta médica, nos termos do requerido na exordial.

Diante do exposto, julgo **PROCEDENTES** os pedidos formulados por **V. G. D. S.** e **TIANE JOHN GIUSTI** em fade de **CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE** e **DETERMINO** a ré que autorize e custeie o tratamento do autor na Clínica VOE, em Bom Princípio/RS, enquanto se fizer necessário o tratamento. Outrossim, **CONDENO** a demandada ao reembolso dos valores pagos pelo autor com o referido tratamento, desde a data do laudo acostado no evento 1, LAUDO9. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação, nos seguintes termos: até a data de 28/08/2024, quando entrou em vigor a Lei n. 14.905/2024, incidirão juros de mora de 1% ao mês; a partir desta data, os juros de mora serão aplicados de acordo com a Taxa Selic, deduzido o IPCA (arts. 389, § único, e 406, §1º, do CC).

Condeno a parte ré a pagar as custas processuais e os honorários de advogado, que vão fixados em 10% do valor da condenação atualizado (art. 85, §2º, do CPC).

Decisão publicada e registrada eletronicamente, com partes intimadas.

Em havendo interposição de recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões e remetam-se os autos à instância superior, independente de juízo de admissibilidade, conforme art. 1.010, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, e satisfeitas eventuais despesas processuais remanescentes, arquivem-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA ERTEL WEIRICH, Juíza de Direito**, em 18/02/2025, às 15:33:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10069774611v47** e o código CRC **e346445a**.

---

1. https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_39_2021_terapias_e_metodos_-_transtorno_do_espectro_autista.pdf ↩